



RUMAH SAKIT  
**PRIMA HUSADA**

**PEDOMAN  
PELAYANAN STUNTING DAN WASTING  
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : [sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com](mailto:sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com)

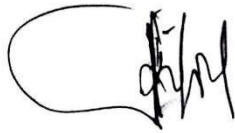
[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**  
**NOMOR: 935.106/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

**TENTANG**  
  
**PEDOMAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING**  
**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Disusun oleh:

Ketua Tim



**(dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed)**

Disetujui oleh:

Authorized Person



**(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)**

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



**(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pelayanan Stunting dan Wasting Rumah Sakit Prima Husada ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Masalah stunting dan wasting masih menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok bayi dan balita. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas di masa depan, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan standar pelayanan, regulasi nasional, serta program percepatan penurunan stunting dan wasting. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta optimalisasi tata laksana kasus secara multidisiplin dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kebutuhan pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan akan terus dilakukan secara berkala guna meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam memberikan pelayanan stunting dan wasting yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien

Pasuruan, 1 November 2025  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



**Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep**

---

**TIM PENYUSUN**  
**PEDOMAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING**

**PENGARAH**

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
2. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

**PENYUSUN**

1. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M.Biomed
2. dr. Achmad Fauzan Ailani
3. Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.
4. Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep.Ns
5. Iin Widowati, S.Tr.Keb
6. Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
7. Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt
8. Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....i

KATA PENGANTAR .....ii

TIM PENYUSUN .....iii

DAFTAR ISI .....iv

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 1

1.2 2

1.3 2

1.4 3

BAB II STANDAR KETENAGAAN.....5

2.1 5

2.2 6

2.3 9

BAB III STANDAR FASILITAS ..... 11

3.1 11

3.2 12

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN..... 14

4.1 14

4.2 14

4.3 15

4.4 16

4.5 21

BAB V LOGISTIK ..... 22

5.1 22

5.2 22

BAB VI KESELAMATAN PASIEN ..... 23

6.1 23

6.2 23

6.3 23

6.4 24

6.5 24

6.6 24

BAB VII KESELAMATAN KERJA..... 26

7.1 26

7.2 26

7.3 26

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU ..... 27

8.1 27

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 8.2                   | 27        |
| 8.3                   | 27        |
| 8.4                   | 27        |
| <b>BAB IX PENUTUP</b> | <b>29</b> |



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  
NOMOR: 935.106/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting dan wasting;
- b. bahwa percepatan penurunan stunting dan wasting dilaksanakan secara integratif dan berkualitas melalui penerapan program pelayanan stunting dan wasting Rumah Sakit Prima Husada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Stunting dan Wasting Rumah Sakit Prima Husada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. PMK No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
6. PMK No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
7. PMK No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
8. PMK No. 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
9. PMK No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
10. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
11. Kepdirjen Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Kepdirjen Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Kepdirjen Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 953.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
15. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PEDOMAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan stunting dan wasting adalah pelayanan kesehatan yang terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan untuk bayi dan balita dengan masalah gizi kronis (stunting) dan/atau gizi akut (wasting) melalui pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kualitas hidup pasien;
- (3) Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yang ditandai dengan PB/U atau TB/U  $< -2$  SD;
- (4) Wasting adalah kondisi kurus yang disebabkan oleh kekurangan gizi akut dan/atau penyakit, yang ditandai dengan BB/PB atau BB/TB  $< -2$  SD. Namun, jika nilainya  $< -3$  SD dan/atau LiLA  $< 11,5$  cm pada balita usia 6-59 bulan yang disertai edema bilateral dikategorikan sebagai Severe Wasting (Gizi Buruk);
- (5) Pasien stunting dan wasting adalah bayi atau balita yang telah teridentifikasi mengalami stunting dan/atau wasting berdasarkan hasil skrining, pengukuran antropometri, dan/atau diagnosis tenaga kesehatan;
- (6) Pelayanan rawat jalan stunting dan wasting adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa perawatan inap dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- (7) Pelayanan rawat inap stunting dan wasting adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit sesuai indikasi medis dan standar tata laksana yang berlaku;
- (8) Penatalaksanaan stunting dan wasting adalah serangkaian tindakan medis dan asuhan gizi yang meliputi deteksi dini, diagnosis, terapi gizi, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan, serta tindak lanjut;

## BAB II STANDAR KETENAGAAN

### Pasal 2 Pembentukan Tim Stunting dan Wasting

- (1) Rumah sakit membentuk tim pelayanan stunting dan wasting melalui SK Direktur;
- (2) Tim yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga kesehatan multidisiplin ilmu yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi;
- (3) Tim pelayanan stunting dan wasting diketuai oleh staf medis atau dokter spesialis anak;





- (4) Yang termasuk dalam keanggotaan tim stunting dan wasting sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Staf medis;
  - b. Staf keperawatan;
  - c. Staf kebidanan;
  - d. Staf instalasi gizi;
  - e. Staf instalasi farmasi;
  - f. Staf humas.

### Pasal 3

#### Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- (1) Tim pelayanan stunting dan wasting mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan seluruh kegiatan pelayanan stunting dan wasting;
- (2) Tim pelayanan stunting dan wasting bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan yang bermutu, aman, tepat sasaran, sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim pelayanan stunting dan wasting berwenang melakukan koordinasi dengan seluruh unit terkait, memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan, memberikan rekomendasi tindak lanjut pelayanan, serta mengusulkan upaya perbaikan dan pengembangan pelayanan stunting dan wasting kepada Direktur Rumah Sakit;
- (4) Tim pelayanan stunting dan wasting berfungsi:
  - a. Fungsi promotif;
  - b. Fungsi preventif;
  - c. Fungsi kuratif;
  - d. Fungsi rehabilitatif;
  - e. Fungsi koordinatif dan integratif;
  - f. Fungsi monitoring dan evaluasi.

### Pasal 4

#### Tata Hubungan Kerja

- (1) Tim pelayanan stunting dan wasting berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tim pelayanan stunting dan wasting menjalin hubungan kerja yang bersifat koordinatif, kolaboratif, dan fungsional dengan seluruh unit pelayanan, penunjang, serta manajemen di rumah sakit dalam rangka penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting yang terintegrasi;
- (3) Tim pelayanan stunting dan wasting bekerja sama dengan tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga gizi, nakes lain, serta unit terkait dalam pelaksanaan skrining, asesmen, intervensi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan stunting dan wasting;
- (4) Tim pelayanan stunting dan wasting dapat berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah, organisasi profesi, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan untuk mendukung keberhasilan program penanganan stunting dan wasting.



### BAB III STANDAR FASILITAS

#### Pasal 5 Standar Bangunan

- (1) Bangunan pelayanan stunting dan wasting minimal terdiri dari:
  - a. Ruang pendaftaran
  - b. Ruang tunggu
  - c. Ruang pemeriksaan
  - d. Ruang konseling gizi
  - e. Ruang rawat inap
  - f. Ruang laktasi
  - g. Ruang pelayanan terpadu;
- (2) Ruang pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi antara pelayanan medis, keperawatan, dan gizi untuk menjamin kesinambungan pelayanan;
- (3) Dalam hal keterbatasan ruang, pelayanan dapat dilakukan secara integratif dengan unit lain tanpa mengurangi mutu pelayanan.

#### Pasal 6 Standar Peralatan

- (1) Rumah sakit menyediakan peralatan pelayanan stunting dan wasting yang aman, bermutu, dan mendukung keselamatan pasien;
- (2) Jenis dan jumlah peralatan disesuaikan dengan jenis pelayanan, jumlah pasien, dan kebutuhan klinis;
- (3) Peralatan yang dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
  - a. Alat antropometri (timbangan, *length board*, *microtoise*);
  - b. Alat ukur status gizi (LiLA, grafik pertumbuhan WHO);
  - c. Alat pemeriksaan tanda vital;
  - d. Peralatan penunjang (laboratorium dasar dan terapi gizi);
  - e. Media edukasi;
- (4) Seluruh peralatan harus dalam kondisi baik, terkalibrasi, dan digunakan sesuai SPO;
- (5) Pengelolaan peralatan dilakukan sesuai dengan standar manajemen fasilitas dan keselamatan pasien;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis peralatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

### BAB IV TATA LAKSANA

#### Pasal 7 Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

- (1) Rumah sakit menyusun program penurunan prevalensi stunting dan wasting yang terdiri dari:
  - a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting melalui edukasi terintegrasi;



- b. Pelaksanaan intervensi spesifik sesuai dengan indikasi;
  - c. Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;
  - d. Rumah sakit berperan sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting;
  - e. Rumah sakit sebagai pendamping klinis serta bagian dari jejaring rujukan pelayanan kesehatan;
  - f. Pelaksanaan program pemantauan dan evaluasi berkala;
- (2) Pelaksanaan program dilakukan dengan prinsip:
- a. Berbasis pasien (*patient-centered care*);
  - b. Kolaborasi multidisiplin;
  - c. Berkesinambungan (*continuity of care*);
  - d. Berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien;
  - e. Terdokumentasi dalam rekam medis;
  - f. Dilakukan monitoring dan evaluasi indikator mutu pelayanan.

#### Pasal 8

##### Rujukan Kasus Gangguan Gizi

- (1) Rumah sakit menetapkan sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut;
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil skrining, asesmen, dan evaluasi oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Rujukan dapat dilakukan secara internal antar unit pelayanan di dalam rumah sakit maupun secara eksternal ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki kemampuan pelayanan lebih sesuai dengan kebutuhan pasien;
- (4) Pelaksanaan rujukan harus disertai dengan informasi klinis, hasil pemeriksaan, diagnosis, intervensi yang telah diberikan, serta rekomendasi tindak lanjut untuk menjamin kesinambungan pelayanan;
- (5) Tim pelayanan stunting dan wasting melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rujukan guna memastikan pasien memperoleh pelayanan lanjutan yang tepat, aman, dan berkesinambungan.

#### Pasal 9

##### Jejaring Rujukan

- (1) Rumah sakit melaksanakan penguatan jejaring rujukan kelas dibawahnya dan FKTP di wilayah kerjanya;
- (2) Rumah sakit melakukan pembinaan jejaring rutin dan berkala;
- (3) Rumah sakit melaksanakan peningkatan SDM jejaring.

#### Pasal 10

##### Intervensi dan Pengelolaan Gizi

- (1) Rumah sakit wajib melaksanakan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi bagi pasien stunting dan wasting secara komprehensif, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar pelayanan, pedoman nasional, serta regulasi yang berlaku;
- (2) Pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan skrining gizi, asesmen gizi,



penetapan diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, evaluasi, edukasi, dan tindak lanjut pelayanan pasien stunting dan wasting.

#### Pasal 11

##### Sistem Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Rumah sakit melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- (2) Pelaporan hasil kegiatan pelayanan stunting dan wasting dilaksanakan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur;
- (3) Rumah sakit melaksanakan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan kasus stunting dan wasting pada SIMRS dan SIRS.

#### BAB V

##### LOGISTIK

#### Pasal 12

##### Perencanaan dan Pengadaan Logistik

- (1) Rumah sakit menjamin ketersediaan logistik khusus untuk pelayanan stunting dan wasting secara berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan medik dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan kebutuhan logistik pelayanan stunting dan wasting dilakukan secara terpadu oleh tim stunting dan wasting bersama instalasi farmasi, instalasi gizi, dan bagian pengadaan rumah sakit;
- (3) Logistik pelayanan stunting dan wasting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Logistik farmasi/medis;
  - b. Logistik nutrisi khusus;
  - c. Logistik alat kesehatan dan antropometri.

#### Pasal 13

##### Penyimpanan, Distribusi dan Pemantauan

- (1) Penyimpanan logistik khusus stunting dan wasting wajib dilakukan di instalasi farmasi dan instalasi gizi sesuai dengan spesifikasi produk guna menjaga stabilitas mutu dan keamanan;
- (2) Pendistribusian logistik ke ruang pelayanan (poli anak/tumbuh kembang, ruang rawat inap, maupun ruang gizi) dilakukan dengan menerapkan sistem FEFO dan FIFO;
- (3) Pemantauan visual, pencatatan kartu stok, dan evaluasi berkala terhadap ketersediaan logistik (kondisi *stock-out* atau *overstock*) dilakukan setiap bulan oleh penanggung jawab logistik dan dilaporkan kepada ketua tim stunting dan wasting.

#### BAB VI

##### KESELAMATAN PASIEN

#### Pasal 14

- (1) Rumah sakit menyusun dan menerapkan program keselamatan pasien dalam pelayanan stunting dan wasting;



- (2) Keselamatan pasien dilaksanakan melalui penerapan 6 sasaran keselamatan pasien yang meliputi:
  - a. Identifikasi pasien dengan benar
  - b. Meningkatkan komunikasi efektif;
  - c. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
  - d. Kepastian tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat tindakan;
  - e. Pencegahan dan pengendalian risiko infeksi;
  - f. Mengurangi risiko pasien jatuh;
- (3) Pelayanan stunting dan wasting dilakukan dengan memperhatikan kondisi klinis pasien, risiko komplikasi, serta standar tata laksana yang berlaku;
- (4) Setiap kejadian yang tidak diharapkan dalam pelayanan dilakukan pelaporan, analisis, dan tindak lanjut sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

## BAB VII KESELAMATAN KERJA

### Pasal 15

- (1) Rumah sakit menyusun dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelayanan stunting dan wasting;
- (2) Program K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung dari risiko kecelakaan dan paparan bahaya selama pelayanan;
- (3) Pelaksanaan keselamatan kerja meliputi:
  - a. Penggunaan APD sesuai kebutuhan;
  - b. Pengelolaan limbah medis dan non medis;
  - c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - d. Penanganan bahan berbahaya dan berisiko;
  - e. Edukasi dan pelatihan keselamatan kerja bagi petugas;
- (4) Rumah sakit memastikan lingkungan kerja aman dan mendukung pelayanan stunting dan wasting secara optimal.

## BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

### Pasal 16

- (1) Rumah sakit melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) pada pelayanan stunting dan wasting;
- (2) Pengendalian mutu dilakukan melalui:
  - a. Penetapan indikator mutu pelayanan
  - b. Pengumpulan dan analisis data secara berkala
  - c. Audit klinis dan audit rekam medis
  - d. Tindak lanjut perbaikan berkelanjutan;
- (3) Hasil evaluasi mutu digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan dan pengambilan keputusan manajemen.



BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 2148.181/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2022 tentang Panduan Pelayanan Tim Stunting dan Wasting dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 1 November 2025  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



**Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep**

**PEDOMAN PELAYANAN STUNTING DAN WASTING**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Stunting dan wasting merupakan dua bentuk masalah gizi balita yang mencerminkan kondisi kekurangan gizi kronis dan akut. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam waktu lama yang ditandai dengan panjang/tinggi badan menurut umur berada di bawah standar. Sementara itu, wasting adalah kondisi kurus yang disebabkan oleh kekurangan gizi akut atau penyakit infeksi, ditandai dengan berat badan menurut panjang/tinggi badan yang rendah. Kedua kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, kerentanan terhadap penyakit, serta produktivitas di masa depan.

Secara global, prevalensi stunting pada balita diperkirakan sekitar 22%, sedangkan wasting sekitar 6–7% dari total sekitar 148 juta balita di dunia (WHO, UNICEF, & World Bank, 2023). Di Indonesia, prevalensi stunting berdasarkan SSGI tahun 2022 sebesar 21,6%, sedangkan wasting sekitar 7,7% (Kemenkes RI, 2022). Pada tingkat provinsi, Jawa Timur memiliki prevalensi stunting sekitar 19–20% dan wasting sekitar 6–7% (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2022). Sementara itu, di tingkat kabupaten, Kabupaten Pasuruan prevalensi stunting dilaporkan masih berada pada kisaran sekitar 20% dan wasting sekitar 7% (Profil Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus stunting dan wasting masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai tingkatan wilayah yang masih memerlukan upaya penanganan.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran penting dalam penanganan kasus stunting dan wasting melalui penyelenggaraan pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pelayanan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh tim multidisiplin sesuai kompetensi. Intervensi yang diberikan mencakup skrining dan deteksi dini, penegakan diagnosis, tata laksana medis, terapi gizi, pemantauan pertumbuhan-perkembangan, serta edukasi-konseling kepada keluarga.

Sejalan dengan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting, rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarpras yang memadai, serta sistem rujukan yang efektif. Selain itu, penerapan SNARS juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui manajemen risiko, koordinasi antar unit, serta kesinambungan pelayanan (*continuity of care*), termasuk perencanaan pemulangan pasien dan rujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Rumah Sakit Prima Husada sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan stunting dan wasting yang profesional, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelayanan yang menjadi acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

---

Pedoman Pelayanan Stunting dan Wasting ini disusun sebagai landasan operasional bagi seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara komprehensif, multidisiplin, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi yang berlaku. Dengan tersusunnya pedoman ini, diharapkan pelayanan stunting dan wasting di Rumah Sakit Prima Husada dapat berjalan dengan optimal, terstandar, dan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien.

## 1.2 Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Terselenggaranya pelayanan stunting dan wasting di rumah sakit secara komprehensif, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien untuk meningkatkan status gizi dan kualitas tumbuh kembang anak sesuai standar pelayanan dan akreditasi.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- b. Menjamin terlaksananya skrining, deteksi dini, dan penegakan diagnosis secara tepat dan terstandar.
- c. Menjamin terselenggaranya penatalaksanaan medis dan asuhan gizi secara terpadu oleh tim multidisiplin.
- d. Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam pelayanan yang meliputi pencegahan komplikasi gizi buruk, pencegahan infeksi, keamanan pemberian terapi gizi dan obat serta pemantauan kondisi klinis pasien.
- e. Menjamin kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) melalui koordinasi antar unit, rujukan, dan rujuk balik.
- f. Meningkatkan peran edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga terkait perbaikan gizi dan pola asuh.
- g. Mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan stunting dan wasting.
- h. Mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit terkait pelayanan gizi dan keselamatan pasien.
- i. Meningkatkan mutu pelayanan melalui monitoring, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

## 1.3 Ruang Lingkup

### 1. Pasien

- a. Bayi dan balita (0-59 bulan) yang datang ke rumah sakit dengan kondisi:
  - 1) Risiko stunting dan/atau wasting
  - 2) Stunting
  - 3) Wasting
  - 4) Gizi kurang dan/atau gizi buruk
  - 5) Penyakit penyerta (infeksi, diare, pneumonia, dll)
- b. Bayi dan balita dengan kondisi khusus, antara lain:
  - 1) Berat badan lahir rendah (BBLR)
  - 2) Riwayat prematuritas
  - 3) Gangguan tumbuh kembang
  - 4) Masalah pemberian makan (*feeding difficulties*)
  - 5) Komplikasi gizi buruk (edema dehidrasi infeksi berat)
- c. Pasien dengan gangguan pertumbuhan yang memerlukan pemantauan dan evaluasi lanjutan secara berkala
- d. Pasien dengan faktor risiko sosial dan lingkungan, termasuk pola asuh yang kurang tepat, keterbatasan akses pangan, dan sanitasi yang tidak memadai.



## 2. Pelayanan

- a. Terlaksananya intervensi gizi spesifik sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dan wasting yang meliputi:
  - 1) Pemberian edukasi program 1000 HPK
  - 2) Pemberian edukasi suplementasi tablet besi folat pada ibu hamil
  - 3) Pemberian PMT pada ibu hamil
  - 4) Promosi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif
  - 5) Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA)
  - 6) Pemantauan pertumbuhan
  - 7) Pemberian imunisasi
  - 8) Pemberian edukasi tentang makanan tambahan balita gizi kurang
  - 9) Pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian vitamin A
  - 10) Pemberian edukasi tentang pemberian taburia pada baduta (0-23 bulan)
  - 11) Pemberian edukasi tentang pemberian obat cacing pada ibu hamil.
- b. Terlaksananya pelayanan sesuai dengan prinsip RSSIB yang meliputi:
  - 1) Terdapat kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi
  - 2) Penyelenggaraan pelayanan antenatal (konseling maternal dan neonatal)
  - 3) Penyelenggaraan persalinan bersih dan aman dan penanganan bayi baru lahir dengan IMD dan kontak kulit ibu-bayi
  - 4) Penyelenggaraan PONEK
  - 5) Penyelenggaraan pelayanan nifas dan rawat gabung ibu-bayi
  - 6) Penyelenggaraan pelayanan rujukan 2 arah dan pembinaan jejaring rujukan
  - 7) Penyelenggaraan pelayanan imunisasi dan tumbuh kembang
  - 8) Penyelenggaraan pelayanan KB
  - 9) Penyelenggaraan audit maternal dan perinatal secara periodik
  - 10) Pemberdayaan kelompok pendukung pemberian ASI Eksklusif
- c. Terlaksananya pelayanan stunting dan wasting secara komprehensif yang meliputi:
  - 1) Pelayanan skrining, deteksi dini status gizi, dan penegakan diagnosis
  - 2) Pelayanan rawat jalan stunting dan wasting
  - 3) Pelayanan rawat inap untuk kasus gizi buruk/komplikasi
  - 4) Pelayanan konsultasi gizi
  - 5) Pelayanan rehabilitasi dan pemantauan tumbuh kembang
  - 6) Pelayanan rujukan dan pembinaan jejaring
- d. Terpenuhinya standar keselamatan pasien dalam seluruh proses pelayanan
- e. Terlaksananya pencatatan, pelaporan, serta monitoring evaluasi pelayanan sebagai bagian dari peningkatan mutu.

### 1.4 Batasan Operasional

#### 1. Batasan Usia Pasien

Pasien sasaran adalah bayi dan balita berusia 0-59 bulan. Anak usia diatas 59 bulan dapat dilayani sesuai indikasi medis terkait gangguan gizi.

#### 2. Batasan Definisi Operasional

- a. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dengan indikator PB/U atau TB/U  $< -2$  SD berdasarkan standar WHO.
- b. Wasting adalah kondisi kurus dengan indicator BB/PB atau BB/TB antara  $< -2$  SD sampai  $-3$  SD.
- c. Severe wasting/gizi buruk adalah kondisi BB/PB atau BB/TB  $< -3$  SD dan/atau disertai tanda klinis seperti edema.
- d. Skrining gizi adalah kegiatan identifikasi dini status gizi menggunakan pengukuran antropometri.
- e. Asesmen gizi adalah penilaian komprehensif status gizi meliputi antropometri, klinis, dan riwayat asupan.
- f. Penatalaksanaan adalah tindakan medis dan asuhan gizi sesuai kondisi pasien

- 
3. Batasan Pelayanan
    - a. Pelayanan diberikan pada unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
    - b. Pelayanan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
    - c. Penatalaksanaan dilakukan oleh tim multidisiplin sesuai kompetensi.
    - d. Pelayanan mengikuti standar nasional dan pedoman klinis yang berlaku.
  4. Batasan Kewenangan
    - a. DPJP menetapkan diagnosis dan rencana terapi medis.
    - b. Tenaga gizi memberikan asuhan gizi dan terapi diet.
    - c. Perawat dan tenaga kesehatan lain melaksanakan asuhan sesuai kewenangan.
    - d. Seluruh tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan SPO.
  5. Batasan Rujukan
    - a. Rujukan internal dilakukan bila membutuhkan pelayanan spesialis/penunjang.
    - b. Rujukan eksternal dilakukan bila fasilitas atau kompetensi tidak tersedia.
    - c. Rujuk balik dilakukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk tindak lanjut.
  6. Batasan Pencatatan dan Pelaporan
    - a. Seluruh pelayanan dicatat dalam rekam medis.
    - b. Data pelayanan dilaporkan sesuai sistem pelaporan yang berlaku.
    - c. Hasil pelayanan digunakan untuk monitoring dan evaluasi mutu.

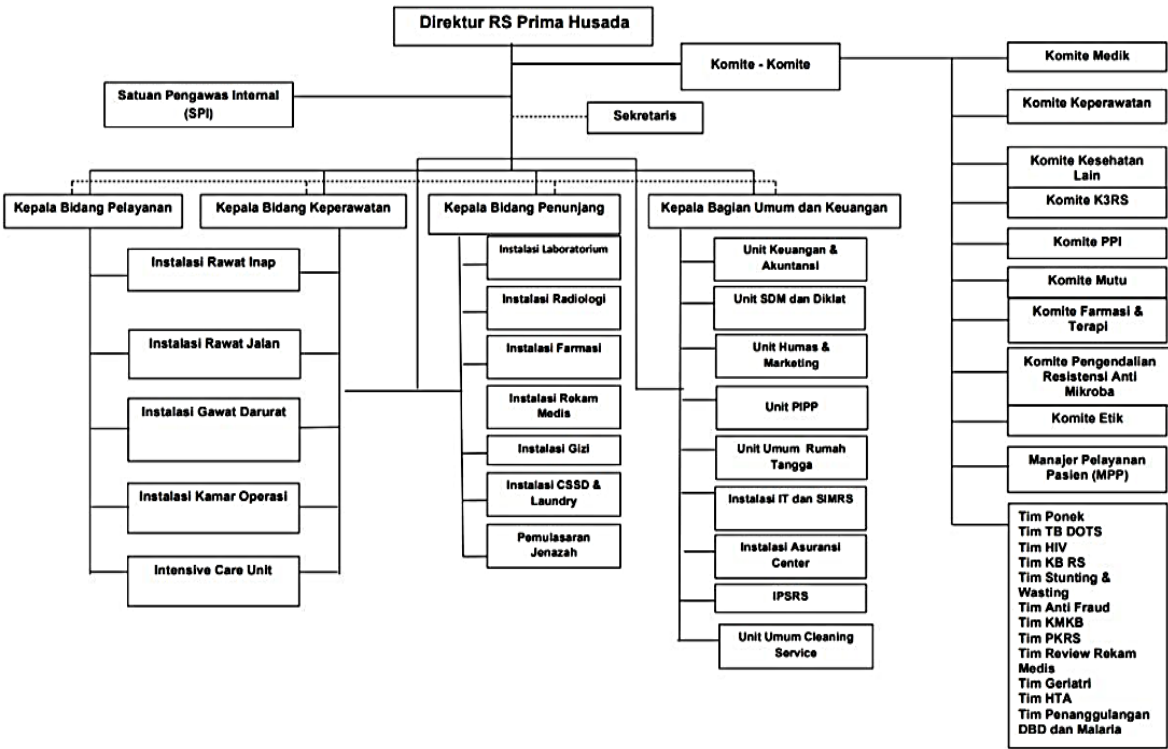
BAB II

STANDAR KETENAGAAN

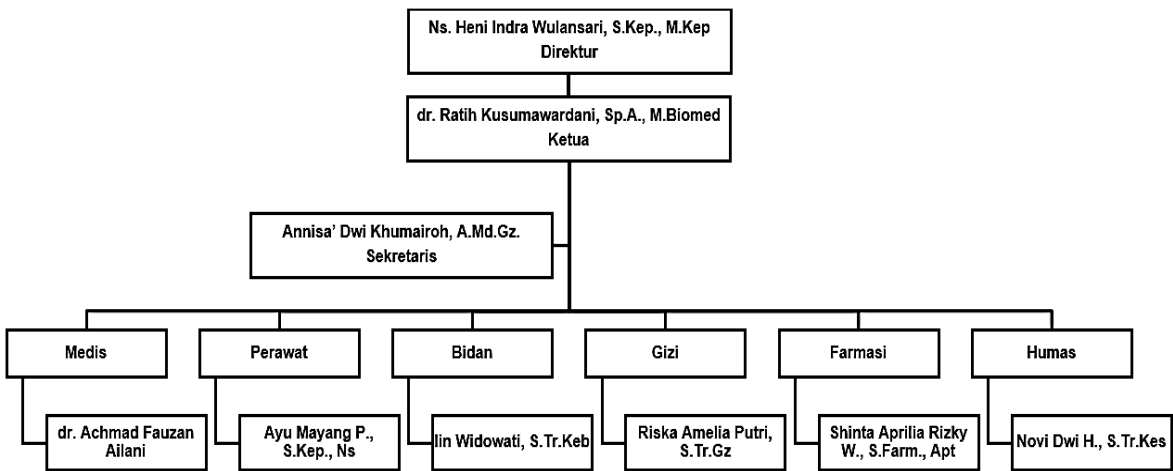
2.1 Struktur Organisasi Tim

Susunan dan struktur keanggotaan tim pelayanan stunting dan wasting di Rumah Sakit Prima Husada antara lain:

- Ketua : dr. Ratih Kusumawardani, Sp. A., M. Biomed
- Sekretaris : Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz
- Anggota :
- Staf Medis : dr. Achmad Fauzan Ailani
- Staf Keperawatan : Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns
- Staf Kebidanan : Iin Widowati, S.Tr.Keb
- Staf Gizi : Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
- Staf Farmasi : Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt
- Staf Humas : Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes



Gambar 2.1 SOTK Rumah Sakit



Gambar 2.2 SOTK Tim Pelayanan Stunting dan Wasting

---

## 2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

### 1. Ketua Tim

#### a. Kualifikasi

- 1) Staf medis, diutamakan DSA, memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
- 2) Memiliki kompetensi dalam penanganan stunting dan wasting
- 3) Memiliki pengalaman pelayanan kesehatan anak di RS (min 3 tahun)
- 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan, koordinasi, dan manajemen tim
- 5) Memahami pedoman nasional penanganan stunting dan wasting serta standar pelayanan rumah sakit.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim
- 2) Menyusun kebijakan teknis serta strategi pelaksanaan pelayanan
- 3) Mengarahkan skrining, diagnosis, tata laksana, dan pemantauan pasien
- 4) Mengkoordinasikan kerja sama antar profesi dalam tim pelayanan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
- 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada pimpinan rumah sakit
- 7) Mengembangkan peningkatan mutu pelayanan melalui pelatihan, audit klinis, dan evaluasi pelayanan.

#### c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan stunting dan wasting yang efektif, terpadu, dan sesuai standar pelayanan
- 2) Menjamin koordinasi antar tenaga kesehatan dalam tim berjalan baik
- 3) Menjamin pelayanan diberikan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan keselamatan pasien
- 4) Bertanggung jawab atas pencapaian mutu pelayanan stunting dan wasting
- 5) Bertanggung jawab terhadap laporan, data, dan semua informasi yang dikeluarkan oleh tim sebagai hasil pelaksanaan program kepada pimpinan rumah sakit dan ataupun dari dinas terkait.

#### d. Wewenang

- 1) Menunjuk dan menetapkan sekretaris dan anggota tim
- 2) Menetapkan rencana kerja dan kegiatan tim
- 3) Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam pelayanan
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tim
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit terkait pengembangan pelayanan stunting dan wasting
- 6) Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program stunting dan wasting sesuai dengan perundang-undangan.

### 2. Sekretaris Tim

#### a. Kualifikasi

- 1) Tenaga kesehatan/tenaga administrasi kesehatan yang ditunjuk oleh ketua
- 2) Memiliki pendidikan minimal D-III
- 3) Memiliki kemampuan administrasi, koordinasi, dan pengelolaan dokumen
- 4) Memahami sistem pelaporan dan pencatatan pelayanan kesehatan
- 5) Mampu bekerjasama dengan seluruh anggota tim.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Mengelola administrasi kegiatan tim
- 2) Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pertemuan tim
- 3) Menyiapkan dokumen, laporan, dan notulen rapat tim
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan pelayanan
- 5) Mengelola data dan dokumentasi kegiatan tim
- 6) Mendukung kelancaran koordinasi antar anggota tim.

- 
- c. Tanggung Jawab
    - 1) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi dan dokumentasi
    - 2) Menjamin ketepatan dan keteraturan pencatatan serta pelaporan kegiatan
    - 3) Mendukung pelaksanaan program tim agar efektif dan terkoordinasi
    - 4) Bertanggung jawab pada ketua tim.
  - d. Wewenang
    - 1) Mengelola dan menyimpan dokumen kegiatan tim
    - 2) Menghimpun data dan laporan dari anggota tim
    - 3) Menyampaikan informasi kegiatan tim kepada seluruh anggota tim
    - 4) Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja lingkungan rumah sakit dan pihak luar melalui surat tertulis, email, ataupun telepon
    - 5) Menyusun laporan kegiatan kepada ketua tim dan pimpinan rumah sakit.
3. Anggota Tim
- a. Staf Medis
    - 1) Kualifikasi
      - a) Dokter umum yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
      - b) Memiliki kompetensi dalam pelayanan kegawat daruratan dan penatalaksanaan awal masalah kesehatan anak.
      - c) Memahami skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal kasus stunting dan wasting pada bayi dan anak
      - d) Mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dalam pelayanan
    - 2) Uraian Tugas
      - a) Melakukan skrining awal pasien dengan dugaan stunting dan wasting melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pengukuran antropometri.
      - b) Menegakkan diagnosis awal dan memberi tata laksana sesuai kondisi
      - c) Menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan
      - d) Melakukan stabilisasi pasien apabila terdapat komplikasi
      - e) Berkoordinasi dengan DSA dan tim pelayanan stunting dan wasting
      - f) Melakukan rujukan internal atau eksternal bila diperlukan
      - g) Mendokumentasikan pelayanan dalam rekam medis.
    - 3) Tanggung Jawab
      - a) Bertanggung jawab atas ketepatan diagnosis awal dan penatalaksanaan medis pasien
      - b) Menjamin pelayanan medis diberikan sesuai standar profesi dan prosedur yang berlaku
      - c) Menjamin keselamatan pasien selama pelayanan di IGD.
    - 4) Wewenang
      - a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian klinis pasien
      - b) Menetapkan diagnosis awal dan tindakan medis yang diperlukan
      - c) Meresepkan obat serta meminta pemeriksaan penunjang
      - d) Melakukan konsultasi atau rujukan pada DSA atau unit terkait.
  - b. Staf Keperawatan
    - 1) Kualifikasi
      - a) Pendidikan minimal Diploma III Keperawatan atau Profesi Ners
      - b) Memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku
      - c) Memiliki kompetensi dalam asuhan keperawatan anak dan pemantauan status gizi
    - 2) Uraian Tugas
      - a) Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien stunting dan wasting
      - b) Melakukan pengukuran tanda vital dan antropometri pasien
      - c) Memberikan asuhan keperawatan sesuai rencana terapi medis
      - d) Membantu pemantauan pemberian nutrisi dan terapi
      - e) Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.

- 
- 3) Tanggung Jawab
    - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan
    - b) Memastikan keselamatan pasien selama perawatan.
  - 4) Wewenang
    - a) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi
    - b) Melakukan pemantauan kondisi dan melaporkan pada dokter.
- c. Staf Kebidanan
- 1) Kualifikasi
    - a) Pendidikan minimal Diploma III Kebidanan atau Profesi Bidan
    - b) Memiliki STR dan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) yang masih berlaku
    - c) Memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan pertumbuhan balita.
  - 2) Uraian Tugas
    - a) Melakukan skrining awal risiko stunting dan wasting pada bayi
    - b) Melakukan pengukuran antropometri (BB, PB/TB, lingkar kepala)
    - c) Memberikan edukasi pada ibu mengenai ASI, MP-ASI, pola asuh gizi
    - d) Mendukung pemantauan tumbuh kembang anak.
    - e) Berkoordinasi dengan dokter dan tenaga gizi dalam pelayanan pasien
  - 3) Tanggung Jawab
    - a) Menjamin ketepatan pengukuran pertumbuhan bayi dan balita
    - b) Melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai standar profesi dan SPO.
  - 4) Wewenang
    - a) Melakukan pelayanan kebidanan sesuai kompetensi
    - b) Melakukan deteksi dini masalah tumbuh kembang anak
    - c) Memberikan konseling kesehatan ibu dan anak.
- d. Staf Gizi
- 1) Kualifikasi
    - a) Pendidikan minimal Diploma III atau Sarjana Gizi/Nutrisi
    - b) Memiliki STR Tenaga Gizi dan SIP yang masih berlaku
    - c) Memiliki kompetensi dalam asuhan gizi klinik pada anak.
  - 2) Uraian Tugas
    - a) Melakukan pengkajian status gizi pasien
    - b) Menetapkan diagnosis gizi
    - c) Menyusun intervensi gizi dan rencana diet pasien
    - d) Memberikan konseling gizi kepada pasien dan keluarga
    - e) Memantau dan mengevaluasi intervensi gizi yang diberikan.
  - 3) Tanggung Jawab
    - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan gizi pasien
    - b) Menjamin kesesuaian diet dengan kondisi klinis pasien,
  - 4) Wewenang
    - a) Menentukan rencana diet pasien
    - b) Memberikan edukasi dan konseling gizi.
- e. Staf Farmasi
- 1) Kualifikasi
    - a) Pendidikan minimal Diploma III Farmasi atau Profesi Apoteker
    - b) Memiliki STR Tenaga Kefarmasian dan SIPA/SIK yang masih berlaku
    - c) Memahami pelayanan farmasi klinik
  - 2) Uraian Tugas
    - a) Menyediakan obat sesuai resep dokter
    - b) Melakukan verifikasi resep dan memastikan ketepatan obat
    - c) Memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan
    - d) Memantau penggunaan obat pada pasien.

- 3) Tanggung Jawab
  - a) Menjamin ketersediaan dan keamanan obat
  - b) Menjamin penggunaan obat yang rasional
- 4) Wewenang
  - a) Melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
  - b) Memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan.
- f. Staf Humas
  - 1) Kualifikasi
    - a) Pendidikan minimal Sarjana Kesehatan Masyarakat, Komunikasi, atau bidang terkait
    - b) Memiliki kompetensi dalam promosi kesehatan dan komunikasi publik
  - 2) Uraian Tugas
    - a) Melaksanakan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan terkait stunting dan wasting
    - b) Menyusun media informasi, edukasi, dan komunikasi
    - c) Mendukung kegiatan penyuluhan dan kampanye kesehatan
    - d) Mengelola informasi dan publikasi program stunting dan wasting.
  - 3) Tanggung Jawab
    - a) Menjamin penyampaian informasi kesehatan yang benar dan mudah dipahami masyarakat
    - b) Mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting dan wasting.
  - 4) Wewenang
    - a) Mengembangkan media komunikasi kesehatan
    - b) Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit dan masyarakat.

### 2.3 Tata Hubungan Kerja

- 1. Tata hubungan kerja dengan Direktur Rumah Sakit
  - a. Tim menyampaikan rencana kerja, kebutuhan sumber daya, dan usulan program kepada Direktur.
  - b. Tim menyampaikan laporan kegiatan, capaian indikator, dan hasil evaluasi secara berkala kepada Direktur.
  - c. Direktur memberikan arahan, persetujuan, dan kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting.
  - d. Direktur melakukan evaluasi terhadap capaian program dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
- 2. Tata hubungan kerja dengan seluruh unit rumah sakit
  - a. Unit pelayanan (rawat jalan, rawat inap, IGD, dan poliklinik terkait) dalam pelaksanaan skrining, asesmen, intervensi, pemantauan, edukasi, dan tindak lanjut pasien.
  - b. Unit penunjang (instalasi gizi, laboratorium, farmasi, radiologi, rehabilitasi medik, dan rekam medis) dalam mendukung pemeriksaan, terapi, pelayanan gizi, dokumentasi, serta pelaporan kasus stunting dan wasting.
  - c. Unit manajemen (direksi, komite mutu, komite medik, komite keperawatan, diklat, PKRS, dan unit terkait lainnya) dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, peningkatan mutu, dan pengembangan kompetensi SDM.
  - d. Jejaring pelayanan kesehatan (FKTP, rumah sakit jejaring, dan Dinas Kesehatan) dalam pelaksanaan sistem rujukan, rujuk balik, pembinaan jejaring, serta tindak lanjut pasien.
- 3. Tata hubungan kerja dengan tenaga kesehatan

Tim pelayanan stunting dan wasting bekerja sama dengan tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lainnya, serta unit terkait dalam

---

penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting secara terpadu dan berkesinambungan, kerja sama tersebut meliputi:

- a. Skrining, untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko atau mengalami stunting dan wasting.
- b. Asesmen, untuk menentukan kondisi klinis, status gizi, faktor risiko, dan kebutuhan pasien.
- c. Intervensi, berupa pelayanan medis, asuhan keperawatan, terapi gizi, edukasi, dan tindakan lain sesuai kebutuhan pasien.
- d. Pemantauan dan evaluasi, untuk menilai perkembangan kondisi pasien dan efektivitas intervensi yang diberikan.
- e. Tindak lanjut, melalui kontrol berkala, rujukan, rujuk balik, edukasi keluarga, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan jejaring guna menjamin kesinambungan pelayanan.

4. Tata hubungan kerja eksternal

Tim pelayanan stunting dan wasting dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung keberhasilan program penanganan stunting dan wasting. Koordinasi dan kerja sama tersebut meliputi:

- a. Penguatan sistem rujukan dan rujuk balik pasien stunting dan wasting.
- b. Pertukaran informasi dan data yang mendukung pelayanan dan tindak lanjut pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pembinaan, konsultasi, dan pendampingan teknis terkait pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
- d. Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, termasuk edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- e. Monitoring dan evaluasi program secara berkala untuk meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan.



---

## BAB III

### STANDAR FASILITAS

#### 3.1 Standar Bangunan

##### 1. Kriteria Umum Bangunan

###### a. Konstruksi bangunan

Bangunan pelayanan stunting dan wasting harus memenuhi standar keselamatan, kuat, dan aman untuk mendukung pelayanan yang efektif dan berkesinambungan.

###### b. Jalan dan akses

Akses menuju ruang pelayanan harus mudah dijangkau, rata, tidak licin, serta ramah bagi pasien anak dan pengguna kursi roda.

###### c. Pintu

Pintu ruang pelayanan harus memiliki ukuran yang memadai, mudah dibuka, dan aman untuk mendukung mobilitas pasien, alat medis, serta menjamin keselamatan anak

###### d. Dinding

Dinding ruangan harus kuat, rata, mudah dibersihkan, berwarna cerah, tidak memiliki sudut tajam yang berisiko menimbulkan cedera pada pasien anak.

###### e. Lantai

Lantai harus rata, tidak licin, mudah dibersihkan, dan aman untuk menunjang aktivitas pasien serta mencegah risiko jatuh.

###### f. Langit-Langit

Langit-langit harus kuat dan mudah dibersihkan

###### g. Pencahayaan

Pencahayaan ruangan harus cukup, merata, dan tidak menyilaukan untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien.

###### h. Ventilasi dan sirkulasi udara

Ventilasi dan sirkulasi udara harus baik serta memenuhi standar kesehatan, baik melalui ventilasi alami maupun mekanik yang dilengkapi dengan filter anti bakteri.

###### i. Kamar mandi/toilet

Kamar mandi/toilet harus bersih, aman, tidak licin, serta dilengkapi pegangan untuk mencegah risiko jatuh pada pasien.

###### j. Air

Ketersediaan air bersih harus mencukupi, memenuhi standar kesehatan, dan tersedia secara terus-menerus untuk mendukung pelayanan, kebersihan, serta pencegahan infeksi.

###### k. Keselamatan lingkungan

Lingkungan pelayanan harus memenuhi standar keselamatan, termasuk ketersediaan sistem pencegahan kebakaran dan pengendalian risiko cedera maupun infeksi.

##### 2. Kriteria Khusus Ruangan

###### a. Ruang pendaftaran

Ruangan ini harus cukup luas untuk penempatan meja kerja, kursi, dan lemari penyimpanan dokumen medis pasien. Letaknya strategis dan mudah terlihat oleh pasien yang datang untuk memudahkan alur pelayanan.

###### b. Ruang tunggu

Ruang tunggu harus bersih, nyaman, aman, dan ramah anak, serta cukup luas untuk menampung pasien dan keluarga. Ruangan dilengkapi tempat duduk yang memadai dan mendukung akses bagi pasien dengan kebutuhan khusus.

###### c. Ruang pemeriksaan

Ruang pemeriksaan berada dekat dengan ruang pendaftaran dan dilengkapi fasilitas pemeriksaan. Ruangan terdiri dari:

- 1) Area pemeriksaan untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik;
  - 2) Tempat tidur periksa;
  - 3) Alat pemeriksaan dasar;
  - 4) Area diskusi atau penjelasan kepada keluarga pasien.
- d. Ruang konseling gizi
- Ruang ini digunakan untuk konsultasi dan edukasi gizi secara individual maupun keluarga. Ruangan harus menjamin privasi pasien serta dilengkapi media edukasi yang mendukung penyuluhan.
- e. Ruang rawat inap
- Ruang rawat inap harus cukup luas dan memenuhi standar keselamatan pasien anak. Sekurang-kurangnya memiliki fasilitas:
- 1) Tempat tidur pasien;
  - 2) Area pemantauan kondisi pasien;
  - 3) Ruang untuk tenaga kesehatan;
  - 4) Kamar mandi/WC yang aman dan bersih;
  - 5) Ventilasi dan pencahayaan yang baik.
- f. Ruang laktasi
- Ruang laktasi disediakan untuk mendukung pemberian ASI dan kenyamanan ibu menyusui. Ruangan harus bersih, tenang, serta dilengkapi kursi menyusui dan fasilitas pendukung lainnya.
- g. Ruang pelayanan terpadu
- Ruang ini digunakan untuk koordinasi dan pelayanan multidisiplin dalam penanganan stunting dan wasting. Ruangan harus mendukung kegiatan diskusi tim, edukasi terpadu, serta perencanaan tindak lanjut pasien

### 3.2 Standar Peralatan

Peralatan pada pelayanan stunting dan wasting meliputi peralatan untuk pemeriksaan, pemantauan pertumbuhan, penatalaksanaan medis, serta asuhan gizi.

#### 1. Peralatan antropometri

Peralatan digunakan untuk menilai status gizi pasien secara akurat, terdiri dari:

- a. Timbangan bayi digital;
- b. Timbangan anak;
- c. Length board (pengukur panjang badan bayi);
- d. Microtoise (pengukur tinggi badan);
- e. Pita LiLA.

#### 2. Peralatan pemeriksaan klinis

Peralatan digunakan untuk pemeriksaan kondisi umum pasien, terdiri dari:

- a. Termometer;
- b. Tensimeter anak;
- c. Stetoskop;
- d. Alat pemeriksaan tanda vital lainnya.

#### 3. Peralatan penunjang gizi

Peralatan digunakan dalam penatalaksanaan terapi gizi, terdiri dari:

- a. Alat pemberian makan (sendok, cangkir, feeding set);
- b. Peralatan persiapan makanan atau susu formula;
- c. Alat bantu pemberian nutrisi sesuai indikasi.

#### 4. Peralatan penunjang diagnostik

Peralatan untuk pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan medis, terdiri dari:

- a. Peralatan laboratorium dasar;
- b. Alat pemeriksaan gula darah;
- c. Alat pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi.

#### 5. Media edukasi

Peralatan untuk mendukung konseling dan edukasi kepada pasien dan keluarga, terdiri dari:

- 
- a. Grafik pertumbuhan WHO;
  - b. Leaflet atau media informasi gizi;
  - c. Alat bantu visual edukasi.
6. Peralatan pencatatan dan pelaporan
- Peralatan yang digunakan untuk dokumentasi pelayanan, terdiri dari:
- a. Rekam medis;
  - b. Formulir asesmen gizi;
  - c. Sistem informasi rumah sakit.
7. Ketentuan umum peralatan
- a. Seluruh peralatan harus dalam kondisi baik, bersih, dan siap pakai;
  - b. Dilakukan kalibrasi dan pemeliharaan secara berkala;
  - c. Digunakan sesuai standar operasional prosedur;
  - d. Dikelola sesuai prinsip keselamatan pasien dan pencegahan infeksi.

---

## BAB IV

### TATA LAKSANA PELAYANAN

#### 4.1 Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Seluruh Staf, Pasien, dan Keluarga tentang Masalah Stunting dan Wasting melalui Edukasi Terintegrasi  
Rumah sakit menyelenggarakan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan secara terintegrasi kepada staf, pasien, keluarga pasien, dan masyarakat mengenai pencegahan, deteksi dini, faktor risiko, serta penanganan stunting dan wasting. Edukasi dilaksanakan melalui penyuluhan kelompok, konseling individu, media cetak, media elektronik, dan media informasi lainnya sesuai kebutuhan sasaran.
2. Pelaksanaan Intervensi Spesifik Sesuai dengan Indikasi  
Rumah sakit melaksanakan intervensi spesifik berdasarkan hasil skrining, asesmen medis, dan asesmen gizi yang meliputi pelayanan konsultasi medis, terapi gizi, suplementasi, tata laksana penyakit penyerta, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta intervensi lain sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan yang berlaku.
3. Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi  
Rumah sakit mendukung upaya pencegahan stunting dan wasting melalui penerapan program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), termasuk promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, rawat gabung, edukasi pemberian makan bayi dan anak, serta dukungan menyusui berkelanjutan.
4. Rumah Sakit Berperan sebagai Pusat Rujukan Kasus Stunting dan Wasting  
Rumah sakit berfungsi sebagai pusat rujukan dalam penanganan kasus stunting dan wasting yang memerlukan pelayanan spesialisik, asesmen lanjutan, intervensi komprehensif, pemantauan berkala, serta koordinasi pelayanan dengan fasilitas kesehatan pengirim rujukan.
5. Rumah Sakit sebagai Pendamping Klinis serta Bagian dari Jejaring Rujukan Pelayanan Kesehatan  
Rumah sakit melaksanakan pendampingan teknis dan klinis kepada fasilitas pelayanan kesehatan jejaring, termasuk rumah sakit kelas di bawahnya, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya melalui konsultasi, koordinasi, pembinaan, serta penguatan sistem rujukan dan rujuk balik kasus stunting dan wasting.
6. Pelaksanaan Program Pemantauan dan Evaluasi Berkala  
Rumah sakit melaksanakan pemantauan dan evaluasi program stunting dan wasting secara berkala melalui pengumpulan data, pencatatan, pelaporan, analisis capaian indikator, audit kasus, rapat evaluasi, serta penyusunan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan keberhasilan program.

#### 4.2 Rujukan Kasus Gangguan Gizi

1. Identifikasi dan Skrining  
Tenaga kesehatan melakukan skrining status gizi pada seluruh pasien sesuai kelompok sasaran menggunakan standar yang berlaku.
2. Asesmen  
Pasien yang teridentifikasi mengalami gangguan gizi dilakukan asesmen medis, gizi, keperawatan, dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi.
3. Penetapan Kebutuhan Rujukan  
Tim Pelayanan Stunting dan Wasting bersama dokter penanggung jawab pasien menentukan kebutuhan rujukan berdasarkan:
  - a. Kondisi klinis pasien.
  - b. Status gizi pasien.
  - c. Ketersediaan sumber daya dan fasilitas pelayanan.
  - d. Kompetensi tenaga kesehatan yang tersedia.

#### 4. Pelaksanaan Rujukan

Rujukan dilakukan dengan:

- a. Menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga.
- b. Menyiapkan surat rujukan dan resume medis.
- c. Melampirkan hasil pemeriksaan yang relevan.
- d. Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan tujuan.
- e. Mendokumentasikan proses rujukan dalam rekam medis.

#### 5. Tindak Lanjut dan Rujuk Balik

Setelah pasien mendapatkan pelayanan di fasilitas tujuan, dilakukan:

- a. Pemantauan hasil rujukan.
- b. Koordinasi tindak lanjut pelayanan.
- c. Rujuk balik ke fasilitas asal apabila kondisi pasien telah stabil.
- d. Pendampingan lanjutan sesuai kebutuhan.

#### 6. Rujukan Internal

Rujukan internal dilakukan antar unit pelayanan di rumah sakit, meliputi:

- a. Poli anak.
- b. Poli gizi.
- c. Poli kebidanan dan kandungan.
- d. Rawat inap anak.
- e. Instalasi gizi.
- f. Laboratorium.
- g. Rehabilitasi medik.
- h. Unit pelayanan lain sesuai kebutuhan pasien.

#### 7. Rujukan Eksternal

Rujukan eksternal dilakukan kepada:

- a. Rumah sakit dengan kemampuan pelayanan yang lebih tinggi.
- b. Rumah sakit jejaring.
- c. Puskesmas.
- d. Klinik.
- e. Fasilitas kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

### 4.3 Jejaring Rujukan

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Jejaring rujukan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien dengan masalah gizi, stunting dan wasting sesuai kebutuhan klinis.
- b. Rujukan dilakukan secara berjenjang dari FKTP ke FKRTL sesuai sistem rujukan nasional dan ketentuan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- c. Rumah sakit sebagai FKRTL berperan sebagai pusat rujukan, pembinaan, konsultasi, dan pendampingan kasus gangguan gizi bagi FKTP dan rumah sakit jejaring di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan rujukan mengutamakan keselamatan pasien, ketepatan waktu, efektivitas pelayanan, dan kontinuitas asuhan gizi.

#### 2. Kriteria Rujukan dari FKTP ke FKRTL

Pasien dirujuk ke rumah sakit apabila ditemukan salah satu kondisi berikut:

- a. Balita stunting yang perlu pemeriksaan lanjutan/penanganan multidisiplin.
- b. Balita wasting dengan komplikasi medis/kondisi klinis yang memerlukan perawatan rumah sakit.
- c. Balita gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi yang memerlukan tata laksana sesuai pedoman nasional.
- d. Gangguan pertumbuhan tidak menunjukkan perbaikan setelah intervensi di FKTP.
- e. Terdapat penyakit penyerta seperti infeksi berat, kelainan bawaan, gangguan metabolik, penyakit kronis, atau kondisi lain yang memengaruhi status gizi.
- f. Kasus yang memerlukan pemeriksaan penunjang atau konsultasi spesialis.

### 3. Persyaratan Rujukan

- a. Surat rujukan dari FKTP yang memuat identitas pasien, diagnosis, hasil skrining, dan alasan rujukan.
- b. Data antropometri terbaru meliputi berat badan, panjang/tinggi badan, lingkaran lengan atas (bila tersedia), dan hasil penilaian status gizi.
- c. Riwayat intervensi yang telah diberikan di FKTP.
- d. Hasil pemeriksaan penunjang yang tersedia.
- e. Formulir atau dokumen rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 4. Tata Cara Rujukan

- a. FKTP melakukan skrining, asesmen awal, dan menentukan kebutuhan rujukan.
- b. FKTP memberikan stabilisasi awal sesuai kondisi pasien sebelum dirujuk.
- c. FKTP mengirimkan surat rujukan beserta dokumen pendukung kepada rumah sakit tujuan.
- d. Rumah sakit menerima, melakukan verifikasi, dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.
- e. Tim Pelayanan Stunting dan Wasting melakukan asesmen lanjutan, intervensi, pemantauan, dan evaluasi pasien.

### 5. Rujuk Balik

- a. Pasien yang telah stabil dan tidak memerlukan pelayanan spesialisik dapat dirujuk balik ke FKTP.
- b. Rumah sakit memberikan resume medis, hasil asesmen gizi, rencana tindak lanjut, serta rekomendasi pemantauan kepada FKTP.
- c. FKTP melanjutkan pemantauan pertumbuhan, edukasi keluarga, dan intervensi gizi sesuai rekomendasi rumah sakit.

### 6. Koordinasi dan Pembinaan Jejaring

- a. Rumah sakit melakukan koordinasi rutin dengan FKTP dan fasilitas kesehatan jejaring.
- b. Rumah sakit memberikan konsultasi teknis, pendampingan kasus, dan pembinaan terkait pelayanan stunting dan wasting.
- c. Pertemuan koordinasi jejaring dilaksanakan secara berkala untuk evaluasi sistem rujukan dan tindak lanjut kasus.
- d. Hasil pembinaan dan koordinasi didokumentasikan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi program.

## 4.4 Intervensi dan Pengelolaan Gizi

### 1. Surveilans Gizi

#### a. Prosedur Tata Laksana Stunting

Tata laksana stunting berkaitan erat dengan pendekatan interdisiplin yang mencakup aspek medik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, salah satunya dengan pemberian intervensi gizi spesifik. Intervensi Gizi Spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berkontribusi pada 30% penurunan prevalensi stunting. Kegiatan intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Prima Husada terbagi menjadi beberapa kelompok sasaran, antara lain:

#### 1) Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil

- a) Pemberian edukasi mengenai pentingnya program 1000 HPK.
- b) Pemberian edukasi mengenai pentingnya suplementasi tablet besi folat untuk mencegah dan mengatasi anemia selama kehamilan.
- c) Pemberian edukasi tentang pentingnya obat cacing untuk mengatasi cacingan.
- d) Pemberian PMT pada ibu hamil saat kegiatan senam hamil.

#### 2) Intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-23 Bulan

- a) Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/kolostrum).

- b) Mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- c) Mendorong pemberian ASI hingga 23 bulan yang didampingi dengan MP-ASI.
- d) Mendorong pemberian imunisasi lengkap.
- e) Pemantauan pertumbuhan.
- f) Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang.
- g) Pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian vitamin A sesuai program pemerintah.
- h) Pemberian edukasi tentang pemberian taburia pada baduta sesuai dengan program pemerintah.

Selain pemberian intervensi gizi spesifik sebagai upaya promotif-preventif, adapula tata laksana kuratif-rehabilitatif untuk penanganan stunting. Berikut merupakan tata laksana penyelenggaraan pelayanan stunting (rawat jalan/inap) di Rumah Sakit Prima Husada:

- 1) Penerimaan Pasien  
Pasien bayi dan anak (0-59 bulan) datang melalui IGD, rawat jalan, atau rujukan dilakukan registrasi sesuai prosedur rumah sakit.
- 2) Skrining dan Deteksi Dini  
Seluruh pasien yang datang dengan masalah pertumbuhan dan/atau dengan penyakit kronis dilakukan identifikasi faktor risiko (riwayat BBLR, prematur, infeksi berulang, pola asuh) dan skrining status gizi.
- 3) Anamnesis  
Dilakukan secara komprehensif meliputi riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat pemberian ASI dan MP-ASI, riwayat penyakit infeksi (diare, ISPA, TB, dll), riwayat imunisasi, riwayat sosial ekonomi dan pola asuh.
- 4) Pemeriksaan Fisik  
Dilakukan dengan penilaian status umum dan tanda vital, pemeriksaan tanda klinis malnutrisi, dan penilaian tumbuh kembang anak.
- 5) Pengukuran Antropometri  
Dilakukan pengukuran PB/TB, lingkaran kepala (pada anak tertentu) lalu diinterpretasi hasilnya menggunakan kurva WHO. Pengukuran antropometri pada stunting harus dilakukan menurut prosedur pengukuran standar meliputi teknik, alat timbang dan ukur, plotting serta interpretasi hasil. Metode pengukuran yang tidak tepat dapat menimbulkan bias pengukuran yang berefek pada ketidakvalidan diagnosis.
- 6) Pemeriksaan Penunjang  
Pemeriksaan laboratorium dilakukan jika terdapat *red flags* atau jika hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan hal-hal yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut, biasanya terdiri dari pemeriksaan darah, urin, dan feses atau pemeriksaan pencitraan usia tulang (anak diatas 2 tahun), toraks, dan otak serta dapat juga dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa skrining TBC pada pasien yang terindikasi.
- 7) Penegakan Diagnosis  
Diagnosis stunting ditegakan oleh DSA apabila hasil pengukuran antropometri PB/U atau TB/U < -2 SD disertai adanya faktor risiko dan temuan klinis.
- 8) Tatalaksana:
  - a) Tata laksana medis  
Dilakukan sesuai kondisi yang mendasari berupa pemberian suplementasi atau pengobatan penyakit penyerta seperti cacingan, ISPA, dll.

- b) Tata laksana nutrisi  
Diberikan sesuai dengan langkah-langkah asuhan nutrisi pediatrik yang terdiri dari penilaian, penentuan kebutuhan energi, penentuan cara pemberian makan, pemilihan jenis makanan, serta monitoring evaluasi. Pasien biasanya diberikan PKMK sesuai dengan indikasi DSA untuk kejar tumbuh dengan komposisi seimbang yang mengutamakan sumber protein hewani (PER 10-15%).
  - c) Tata laksana non-nutrisi  
Pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan, dan hormon pertumbuhan
  - 9) Edukasi dan Konseling  
Dilakukan kepada orang tua/keluarga/pengasuh tentang pola makan seimbang, hygiene sanitasi, dan perawatan anak.
  - 10) Monitoring dan Evaluasi  
Dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi terapi.
  - 11) Pencatatan dan Pelaporan  
Dicatat dalam rekam medis dan dilaporkan dalam SIRS untuk evaluasi mutu.
- b. Prosedur Tata Laksana Wasting
- 1) Tata Laksana Rawat Jalan (Wasting tanpa Komplikasi)
    - a) Penerimaan, skrining, dan deteksi dini  
Pasien bayi dan anak (0-59 bulan) dengan masalah pertumbuhan dan/atau dengan riwayat BB tidak naik atau terjadi penurunan yang datang wajib membawa buku KIA dilakukan registrasi sesuai prosedur rumah sakit lalu dilakukan skrining status gizi.
    - b) Anamnesis dan pemeriksaan fisik  
Dilakukan penggalan riwayat pemberian makan, penyakit infeksi dan pemeriksaan tanda vital dan status klinis.
    - c) Pengukuran antropometri  
Dilakukan pengukuran BB dan PB/TB lalu diinterpretasi hasilnya menggunakan kurva WHO. Pengukuran harus dilakukan menurut prosedur pengukuran standar untuk menghindari bias yang berefek pada ketidakvalidan diagnosis.
    - d) Penegakan diagnosis  
Diagnosis wasting ditegakan oleh DSA apabila hasil pengukuran antropometri BB/PB atau BB/TB  $\geq -3$  sd  $< -2$  SD tanpa disertai komplikasi klinis.
    - e) Tata laksana:
      - (1) Tata laksana medis  
Dilakukan dengan memberikan antibiotik empiris, vitamin A, asam folat, dan obat cacing sesuai dengan usia dan kondisi (bila diperlukan).
      - (2) Tata laksana nutrisi  
Dilakukan pemberian intervensi gizi yang dilakukan dengan cara pemberian konseling PMBA, pemberian PMT berbasis pangan lokal, serta anjuran peningkatan frekuensi dan kualitas makan anak.
    - f) Edukasi  
Dilakukan pemberian edukasi pada orang tua/keluarga/pengasuh terkait pola makan, kebersihan lingkungan, dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai.



- 
- g) Monitoring dan Evaluasi  
Dilakukan penimbangan BB setiap 2 minggu sekali dengan tetap melakukan evaluasi kenaikan BB (target  $\geq 5$  g/kgBB/hari) dan kepatuhan keluarga. Bila tidak ada perbaikan dalam 2-4 minggu dan/atau disertai dengan salah satu kondisi seperti nafsu makan menurun, ada infeksi (ISPA, diare, dll), dehidrasi ringan-sedang, demam persisten, anemia ringan-sedang tanpa adanya edema dan tanda kegawatan berat dilakukan rujukan rawat inap.
  - 2) Tata Laksana Rawat Inap (Wasting dengan Komplikasi)
    - a) Penerimaan  
Pasien masuk melalui IGD/rawat jalan ditempatkan di ruang rawat inap anak.
    - b) Anamnesis dan pemeriksaan fisik  
Dilakukan penggalan riwayat pemberian makan (ASI/MP-ASI), penyakit infeksi, imunisasi, dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
    - c) Pengukuran antropometri  
Dilakukan pengukuran BB dan PB/TB lalu diinterpretasi hasilnya menggunakan kurva WHO.
    - d) Pemeriksaan penunjang  
Dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang sesuai indikasi seperti pengecekan darah, urine, dan feses lengkap.
    - e) Penegakan diagnosis  
Diagnosis wasting ditegakan oleh DSA apabila hasil pengukuran antropometri BB/PB atau BB/TB  $\geq -3$  sd  $< -2$  SD disertai dengan komplikasi ringan-sedang.
    - f) Tata laksana:
      - (1) Tata laksana medis  
Dilakukan dengan pemberian terapi pada penyakit penyerta (antibiotik, antipiretik, dll), rehidrasi pada kondisi dehidrasi ringan-sedang, serta penanganan anemia ringan-sedang sesuai indikasi.
      - (2) Tata laksana nutrisi  
Diberikan diet TKTP sesuai usia dengan frekuensi makan sering dengan porsi kecil, pemberian MP-ASI adekuat dengan tetap mendorong pemberian ASI.
    - g) Edukasi dan konseling  
Dilakukan pemberian edukasi pada orang tua/keluarga/pengasuh terkait pola makan, kebersihan lingkungan, dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai.
    - h) Monitoring dan evaluasi  
Dilakukan monitoring tanda vital setiap shift, penimbangan BB setiap 2-3 hari sekali, pemantauan asupan makan dan evaluasi respon terapi medis dan nutrisi.
    - i) Rencana tindak lanjut  
Dilakukan apabila pasien sudah memenuhi kriteria pulang (kondisi stabil, intake baik, tidak ada komplikasi aktif) dengan rencana kontrol rawat jalan dalam 3-7 hari, pemantauan pertumbuhan berkala, dan kepatuhan diet.
    - j) Pencatatan dan pelaporan  
Dilakukan pencatatan lengkap dalam rekam medis dan dilaporkan dalam SIRS.

- 
- c. Prosedur Tata Laksana Gizi Buruk (*Severe Wasting*)
- 1) Tata Laksana Rawat Jalan (Gizi Buruk tanpa Komplikasi)
    - a) Penerimaan, skrining, dan deteksi dini  
Pasien bayi dan anak (0-59 bulan) dengan masalah pertumbuhan dan/atau dengan riwayat BB tidak naik atau terjadi penurunan yang datang wajib membawa buku KIA dilakukan registrasi sesuai prosedur rumah sakit lalu dilakukan skrining status gizi dan uji nafsu makan.
    - b) Anamnesis dan pemeriksaan fisik  
Dilakukan penggalian riwayat pemberian makan, penyakit penyakit penyerta, pemeriksaan tanda vital, dan identifikasi tanda bahaya.
    - c) Pengukuran antropometri  
Dilakukan pengukuran BB dan PB/TB lalu diinterpretasi hasilnya menggunakan kurva WHO. Pengukuran harus dilakukan menurut prosedur pengukuran standar untuk menghindari bias yang berefek pada ketidakvalidan diagnosis.
    - d) Penegakan diagnosis  
Diagnosis gizi buruk ditegakan oleh DSA apabila hasil pengukuran antropometri BB/PB atau BB/TB  $< -3$  SD atau LiLA  $< 11,5$  cm tanpa disertai komplikasi klinis.
    - e) Tata laksana:
      - (1) Tata laksana medis  
Dilakukan dengan memberikan antibiotik empiris, vitamin A, asam folat, dan obat cacing sesuai dengan usia dan kondisi (bila diperlukan).
      - (2) Tata laksana nutrisi  
Dilakukan dengan pemberian makanan lokal alternatif pengganti RUTF yang sesuai standar dengan tetap mendorong pemberian ASI, MP-ASI, dan makanan tinggi kalori tinggi protein dengan frekuensi sering.
    - f) Edukasi  
Dilakukan pemberian edukasi pada orang tua/keluarga/pengasuh terkait pola makan, kebersihan lingkungan, dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai.
    - g) Monitoring dan Evaluasi  
Dilakukan penimbangan BB setiap 2 minggu sekali dengan tetap melakukan evaluasi kenaikan BB (target  $\geq 5$  g/kgBB/hari) dan kepatuhan keluarga. Bila tidak ada perbaikan dalam 2-4 minggu dan/atau disertai dengan munculnya komplikasi medis, terjadi edema serta tidak lulus uji nafsu makan dilakukan rujukan ke rawat inap.
  - 2) Tata Laksana Rawat Inap (Gizi Buruk dengan Komplikasi)
    - a) Penerimaan dan penapisan  
Pasien masuk melalui IGD/rawat jalan dilakukan penapisan sebelum ditempatkan diruang rawat inap anak, yang meliputi:
      - (1) Penapisan antropometri  
Pengukuran BB, PB/TB, dan LiLA untuk identifikasi status gizi dengan indikator BB/PB atau BB/TB  $< -3$  SD atau LiLA  $< 11,5$  cm yang disertai dengan adanya edema bilateral.
      - (2) Penapisan tanda bahaya  
Dilakukan dengan melihat ada tidaknya kondisi letargi/tidak sadar, kejang, kemampuan minum, muntah berulang, sesak nafas, dan dehidrasi berat. Apabila ditemukan dilakukan stabilisasi segera sesuai protokol kegawatdaruratan.

- (3) Penapisan komplikasi  
Dilakukan dengan melihat ada tidaknya hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, infeksi berat, dan anemia.
- b) Pemeriksaan penunjang  
Dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang sesuai indikasi seperti pengecekan darah, urine, dan feses lengkap.
- c) Penegakan diagnosis  
Diagnosis gizi buruk ditegakan oleh DSA apabila hasil pengukuran antropometri BB/PB atau BB/TB < -3 SD atau LiLA < 11,5 cm yang disertai dengan adanya edema bilateral dengan komplikasi berat.
- d) Tata laksana:  
Dilaksanakan sesuai prinsip 10 langkah tata laksana gizi buruk dan pedoman nasional dengan melakukan monitoring harian berupa BB, intake-output, tanda vital, edema, dan nafsu makan.
  - (1) Fase stabilisasi (hari ke 1-2)
    - (a) Atasi hipoglikemia
    - (b) Atasi hipotermia
    - (c) Rehidrasi hati-hati sesuai indikas
    - (d) Koreksi gangguan elektrolit
    - (e) Pemberian antibiotik empiris rutin
    - (f) Pemberian F-75
    - (g) Suplementasi mikronutrien tanpa Fe di awal fase
  - (2) Fase transisi (hari ke 3-7)
    - (h) Ganti bertahap ke F-100
  - (3) Fase rehabilitasi
    - (i) Kejar tumbuh dengan formula tinggi energi/RUTF
    - (j) Stimulasi tumbuh kembang
- e) Edukasi dan konseling  
Dilakukan pemberian edukasi pada orang tua/keluarga/pengasuh terkait pola makan, kebersihan lingkungan, dan tanda bahaya.
- f) Monitoring dan evaluasi  
Dilakukan monitoring tanda vital setiap shift, penimbangan BB setiap 2-3 hari sekali, pemantauan asupan makan dan evaluasi respon terapi medis dan nutrisi.
- g) Rencana tindak lanjut  
Dilakukan apabila pasien sudah memenuhi kriteria pulang (kondisi stabil, intake baik, tidak ada komplikasi aktif) dengan rencana kontrol rawat jalan dalam 3-7 hari, pemantauan pertumbuhan berkala, dan kepatuhan diet.
- h) Pencatatan dan pelaporan  
Dilakukan pencatatan lengkap dalam rekam medis dan dilaporkan dalam SIRS serta pelaporan dalam Pelita Kesmas.

#### 4.5 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelayanan stunting dan wasting dilakukan oleh setiap 3 bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur. Monitoring dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dalam memperbaiki pelayanan stunting dan wasting yang mencakup bidang pelayanan, SDM, pembiayaan, pelaporan dan fasilitas. Monitoring dilakukan melalui:

1. Analisis hasil pencatatan dan pelaporan
2. Pertemuan/rapat koordinasi
3. Pemantauan internal dilakukan oleh tim jaga yang bersangkutan

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan stunting dan wasting melalui pertemuan berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan (rapat program, rapat kerja). Tolak ukur evaluasi adalah kualitas pelayanan yang baik.

---

## BAB V

### LOGISTIK

#### 5.1 Logistik Suplementasi dan Terapi Gizi (Paket Program)

Pengadaan, pengelolaan, produksi, dan pengawasan logistik paket program stunting dan wasting merupakan tanggung jawab instalasi farmasi dan instalasi gizi di bawah koordinator tim pelayanan stunting dan wasting. Logistik tersebut terdiri dari:

1. Formula nutrisi terapi gizi (produksi internal gizi)
  - a. Formula F75 dan Formula F100  
Rumah sakit tidak melakukan pengadaan siap saji untuk formula ini, melainkan melakukan produksi/pembuatan mandiri secara higienis oleh instalasi gizi sesuai dengan standar resep dan tata laksana gizi buruk Kemenkes RI untuk kasus yang membutuhkan fase stabilisasi dan transisi.
  - b. Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) Komersial Restriksi  
Jenis RUTF atau PKMK spesifik lainnya yang tidak dapat diproduksi mandiri menunggu hibah program dinas kesehatan jika tersedia.
2. Suplemen vitamin A dosis tinggi  
Pengadaan dan pengelolaan oleh instalasi farmasi untuk mendukung pemulihan imunitas dan pencegahan komplikasi pada balita dengan gangguan gizi.
3. Suplemen zat besi  
Rumah sakit tidak melakukan pengadaan Taburia. Namun untuk suplemen zat besi jenis lain tersedia dan dikelola oleh instalasi farmasi guna intervensi kasus anemia defisiensi besi yang menyertai stunting/wasting.
4. Obat cacing (Albendazole/Mebendazole) sebagai tata laksana penyerta pencegahan gangguan gizi, dikelola sesuai standar pelayanan kefarmasian.

#### 5.2 Logistik Non-Paket (Sediaan Farmasi Umum dan Alat Kesehatan)

Instalasi farmasi dan sarana prasarana rumah sakit menyediakan logistik non-paket (generik atau paten dan alat ukur gizi) yang pengadaannya sesuai dengan belanja farmasi serta anggaran rumah sakit. Koordinator tim pelayanan mengajukan pemesanan atau kalibrasi kepada unit terkait:

1. Logistik alat antropometri standar (Kit Gizi)  
Pengadaan dan pengelolaan logistik alat ukur antropometri berkaitan dengan skrining dan asesmen kasus stunting serta wasting merupakan tanggung jawab instalasi rawat jalan dan rawat inap di bawah koordinator pelayanan medik. Kebutuhan logistik antropometri terkait terdiri dari:
  - a. Infantometer / alat ukur panjang badan bayi (akurasi 0,1 cm).
  - b. Microtoise / alat ukur tinggi badan anak (akurasi 0,1 cm).
  - c. Timbangan berat badan digital anak dan bayi, akurasi 10 g (bayi), 100 g (anak).
  - d. Pita Lingkar Lengan Atas (LiLA) untuk deteksi wasting pada balita.
  - e. Tabel/grafik pertumbuhan anak standar WHO (Z-score BB/U, TB/U, BB/PB atau BB/TB).Catatan: Pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi alat ukur dilakukan secara mandiri oleh Rumah Sakit Prima Husada.
2. Logistik dokumentasi dan formulir skrining  
Logistik dokumentasi program pelayanan stunting dan wasting berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan rekam medis pasien, meliputi
  - a. Formulir skrining gizi anak (*Strong-Kids*).
  - b. Asesmen medis khusus gizi.
  - c. Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) atau Kartu Menuju Sehat (KMS).
  - d. Formulir rujukan dan rujuk balik kasus gangguan gizi
  - e. Format pencatatan bulanan dan triwulan program penurunan stunting dan wasting (format pelaporan ke Dinas Kesehatan / aplikasi Pelita Kesmas).

---

## BAB VI

### KESELAMATAN PASIEN

#### 6.1 Identifikasi Pasien

##### 1. Ketentuan Umum

- a. Seluruh pasien yang mendapatkan pelayanan stunting dan wasting wajib dilakukan identifikasi dengan benar sebelum dilakukan skrining, asesmen, pemeriksaan, intervensi, pemberian terapi gizi, pengambilan spesimen, maupun tindakan lainnya.
- b. Identifikasi pasien dilakukan menggunakan minimal dua identitas, yaitu nama lengkap pasien dan tanggal lahir atau nomor rekam medis.
- c. ada pasien bayi dan anak yang belum dapat mengidentifikasi dirinya sendiri, identifikasi dilakukan melalui orang tua, wali, atau pengasuh yang sah serta dicocokkan dengan gelang identitas dan rekam medis.

##### 2. Prosedur

- a. Persiapan.
- b. Verifikasi identitas
- c. Pelaksanaan pelayanan, meliputi:
  - 1) Skrining stunting dan wasting.
  - 2) Pengukuran berat badan, panjang badan, tinggi badan, dan lila.
  - 3) Asesmen medis dan gizi.
  - 4) Pemberian terapi gizi, makanan, vitamin, mineral, dan obat.
  - 5) Pemeriksaan penunjang.
  - 6) Tindakan keperawatan dan medis lainnya.
- d. Penanganan ketidaksesuaian identitas.

#### 6.2 Peningkatan Komunikasi Efektif

##### 1. Ketentuan Umum

- a. Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan stunting dan wasting wajib menerapkan komunikasi yang efektif, akurat, lengkap, jelas, dan tepat waktu.
- b. Komunikasi efektif digunakan dalam seluruh tahapan pelayanan, mulai dari skrining, asesmen, intervensi, pemantauan, evaluasi, rujukan, hingga tindak lanjut pasien.

##### 2. Prosedur

- a. Komunikasi antar tenaga kesehatan
- b. Komunikasi kepada pasien dan keluarga  
Petugas memberikan informasi mengenai:
  - 1) Hasil skrining dan asesmen.
  - 2) Status gizi pasien.
  - 3) Rencana intervensi dan terapi.
  - 4) Edukasi gizi dan pola makan.
  - 5) Jadwal kontrol dan tindak lanjut.
  - 6) Sistem rujukan apabila diperlukan
- c. Komunikasi saat rujukan
- d. Komunikasi saat rujukan

#### 6.3 Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai

##### 1. Ketentuan Umum

- a. Rumah sakit menjamin keamanan penggunaan obat, vitamin, mineral, suplemen, dan produk nutrisi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting sesuai indikasi medis dan standar pelayanan yang berlaku.

- 
- b. Pemberian obat dan suplemen wajib berdasarkan resep atau instruksi tenaga kesehatan yang berwenang serta mempertimbangkan usia, berat badan, status gizi, kondisi klinis, dan penyakit penyerta pasien.
- 2. Prosedur
    - a. Verifikasi resep dan instruksi terapi
    - b. Persiapan obat dan suplemen
    - c. Pemberian obat dan suplemen
- 6.4 Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien
- 1. Ketentuan Umum
    - b. Rumah sakit wajib memastikan bahwa setiap pelayanan stunting dan wasting diberikan kepada pasien yang tepat, dengan prosedur yang tepat, dan di lokasi pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan pasien.
    - c. Seluruh tindakan dan intervensi pada pasien stunting dan wasting harus berdasarkan hasil asesmen, indikasi klinis, dan rencana pelayanan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang berwenang.
    - d. Pelaksanaan pelayanan harus dilakukan pada unit atau lokasi pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien, baik di rawat jalan, rawat inap, ruang perawatan intensif, maupun unit pelayanan lainnya.
  - 2. Prosedur
    - a. Verifikasi pasien
    - b. Verifikasi prosedur
      - Prosedur yang diverifikasi dapat meliputi:
        - 1) Pengukuran antropometri.
        - 2) Asesmen gizi.
        - 3) Pemeriksaan laboratorium.
        - 4) Konsultasi gizi.
        - 5) Pemberian diet khusus.
        - 6) Pemberian vitamin, mineral, atau suplementasi.
    - c. Pelaksanaan tindakan
- 6.5 Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan
- 1. Ketentuan Umum
    - a. Pasien stunting dan wasting, terutama balita dengan gizi kurang, gizi buruk, atau penyakit penyerta, termasuk kelompok yang berisiko tinggi mengalami infeksi sehingga memerlukan kewaspadaan khusus dalam pemberian pelayanan.
    - b. Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan stunting dan wasting wajib mematuhi kebijakan dan prosedur PPI yang berlaku di rumah sakit.
    - c. Pasien dengan penyakit infeksi menular yang menyertai kondisi stunting atau wasting harus mendapatkan pelayanan sesuai prinsip kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi.
  - 2. Prosedur
    - a. Skrining risiko infeksi
    - b. Kebersihan tangan
    - c. Pengelolaan peralatan dan lingkungan
- 6.6 Pengurangan Risiko Cedera Pasien (Risiko Jatuh)
- 1. Ketentuan Umum
    - a. Pasien stunting dan wasting yang mengalami kelemahan fisik, gangguan keseimbangan, keterlambatan perkembangan motorik, gangguan neurologis, anemia, dehidrasi, atau kondisi klinis lainnya harus mendapatkan asesmen risiko jatuh.

- 
- b. Asesmen risiko jatuh dilakukan pada saat pasien masuk rumah sakit, saat terjadi perubahan kondisi klinis, perpindahan unit pelayanan, dan secara berkala selama masa perawatan.
  - c. Orang tua, keluarga, atau pengasuh pasien wajib mendapatkan edukasi mengenai pencegahan risiko jatuh selama pasien berada di rumah sakit.

2. Prosedur

- a. Asesmen risiko jatuh
- b. Identifikasi pasien risiko jatuh
- c. Pelaksanaan pencegahan risiko jatuh
  - 1) Memastikan tempat tidur dalam posisi aman.
  - 2) Memasang pagar tempat tidur bila diperlukan.
  - 3) Menempatkan pasien pada area yang mudah dipantau petugas.
  - 4) Membantu mobilisasi pasien sesuai kondisi klinis.
  - 5) Memastikan alat bantu yang digunakan dalam kondisi aman.
  - 6) Menjaga lingkungan bebas dari benda yang dapat menyebabkan pasien tersandung atau jatuh
- d. Edukasi pasien dan keluarga

---

## **BAB VII**

### **KESELAMATAN KERJA**

#### **7.1 Potensi Risiko Kerja**

Dalam pelayanan stunting dan wasting, potensi risiko kerja yang bisa terjadi meliputi:

1. Risiko biologis : paparan infeksi (TB, diare, ISPA)
2. Risiko fisik : terpeleset, jatuh, cedera saat menangani pasien
3. Risiko kimia : paparan obat, desinfektan
4. Risiko ergonomik : posisi kerja saat mengangkat atau memindahkan pasien
5. Risiko psikososial : kelelahan kerja, stress

#### **7.2 Upaya Pencegahan dan Pengendalian**

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
  - a. Sarung tangan, masker, apron, dan APD lain sesuai indikasi
  - b. Digunakan pada setiap tindakan yang berisiko
2. Penerapan Kebersihan Tangan
  - a. Dilakukan sesuai “5 momen kebersihan tangan”
  - b. Menggunakan sabun atau handrub berbasis alcohol
3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
  - a. Sterilisasi alat medis
  - b. Pengelolaan limbah medis sesuai standar
  - c. Isolasi pasien bila diperlukan
4. Keselamatan dalam Penanganan Pasien
  - a. Teknik yang benar dalam mengangkat/memindahkan pasien
  - b. Penggunaan alat bantu bila diperlukan
  - c. Pencegahan cedera pada petugas
5. Pengelolaan Bahan Berbahaya
  - a. Penyimpanan obat dan bahan kimia sesuai ketentuan
  - b. Pelabelan yang jelas
  - c. Penggunaan sesuai prosedur
6. Pencegahan Kecelakaan Kerja
  - a. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja
  - b. Memastikan lantai tidak licin
  - c. Penggunaan peralatan sesuai standar
7. Kesehatan Petugas
  - a. Pemeriksaan kesehatan berkala
  - b. Manajemen kelelahan kerja

#### **7.3 Tindakan Penanganan**

1. Penanganan pertama pada kecelakaan (P3K)
2. Pelaporan insiden kepada unit terkait maksimal 2x24 jam
3. Dokumentasi kejadian
4. Evaluasi dan tindak lanjut pencegahan



---

## BAB VIII

### PENGENDALIAN MUTU

#### 8.1 Penetapan Indikator Mutu

Berikut adalah indikator mutu pelayanan stunting dan wasting di Rumah Sakit Prima Husada sesuai dengan SK Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 070.2/RSPH/I-PER/DIR/XI/2025:

1. Prevalensi stunting pada balita di rumah sakit dengan standar target 0%.
2. Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita 1x dalam sebulan dengan standar target 100%.
3. Kepatuhan pembinaan jejaring pengelolaan stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali dengan standar target 100%.
4. Kepatuhan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan standar target 100%.

#### 8.2 Pengumpulan dan Analisis Data Secara Berkala

1. Mekanisme Pengumpulan Data  
Data empat indikator mutu utama diambil tiap bulan dari rekam medis, buku register, dan laporan SIMRS oleh petugas mutu tim pelayanan stunting dan wasting.
2. Validasi Data  
Dilakukan validasi berkala oleh komite/tim mutu RS untuk menjamin akurasi dan validitas data sebelum dianalisis
3. Analisis Data
  - a. Data dianalisis bulanan dan triwulan menggunakan grafik tren
  - b. Membandingkan hasil capaian riil dengan standar target (target minimal 100% atau 0% untuk prevalensi stunting
  - c. Melakukan analisis akar masalah (RCA) jika ditemukan target indikator yang tidak tercapai.
4. Pelaporan  
Hasil analisis dilaporkan secara tertulis setiap triwulan kepada Direktur Rumah Sakit dan Komite Mutu

#### 8.3 Audit Klinis dan Audit Rekam Medis

1. Audit Rekam Medis
  - a. Pengambilan sampel rekam medis pasien stunting dan wasting secara berkala setiap bulan.
  - b. Evaluasi kelengkapan pencatatan asuhan gizi (antropometri, plot Z-score) dan kepatuhan pengisian form KIE kelompok/individu.
2. Audit Klinis
  - a. Penilaian kesesuaian tata laksana asuhan medis dan gizi oleh tim asuhan nutrisi (Dokter Spesialis Anak dan Dietisien) berdasarkan Panduan Praktik Klinis (PPK).
  - b. Evaluasi ketepatan pemberian nutrisi (Formula F-75/F-100) serta monitoring klinis pasien gizi buruk.
3. Dokumentasi  
Hasil temuan audit dibahas dalam rapat rutin internal untuk mengidentifikasi kendala kompetensi atau fasilitas.

#### 8.4 Tindak Lanjut Perbaikan

1. Penyusunan Rencana (PDSA)  
Menyusun rencana perbaikan menggunakan siklus *Plan-Do-Study-Action* (PDSA) berdasarkan hasil analisis data atau audit yang tidak mencapai target.

- 
2. Intervensi Perbaikan
    - a. Aspek SDM  
Edukasi ulang/coaching petugas yang tidak patuh melakukan KIE atau kesalahan penapisan antropometri.
    - b. Aspek Sarpras  
Kalibrasi alat ukur berat/tinggi badan secara berkala dan memastikan ketersediaan logistik gizi (nutrisi khusus).
    - c. Aspek Sistem  
Optimalisasi koordinasi dan alur rujukan balik dengan jejaring FKTP (Puskesmas)
  3. Monitoring Evaluasi  
Memantau efektivitas perbaikan pada bulan berikutnya guna memastikan mutu pelayanan meningkat dan konsisten.

---

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Pedoman Pelayanan Stunting dan Wasting ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan bagi semua anggota tim dalam rangka penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting di Rumah Sakit Prima Husada. Penyusunan pedoman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi elemen standar dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), terutama pada aspek pelayanan berfokus pada pasien, keselamatan pasien, manajemen fasilitas dan keselamatan, serta peningkatan mutu pelayanan.

Pedoman pelayanan ini senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebijakan dan peraturan program pelayanan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 01 Januari 2026  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada ,



**Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep**